

ВИНЬЕТКИ

Преэклампсия и эклампсия

Пять вызовов: умеренная и тяжёлая преэклампсия,
послеродовый период, приступ, HELLP, отслойка плаценты



Сначала все задачи, затем все решения. Разборы взяты из уже закрытых задач.
Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Задачи

Случай 1. Изолированное повышение давления

Беременная, 34 года, первая беременность (ЭКО), срок 28 недель. Головная боль. АД 148/96 мм рт. ст. Отеков нет. Самочувствие в целом удовлетворительное. Белок в моче — 0,35 г/сут. Тромбоциты $210 \times 10^9/\text{л}$. Трансаминазы в норме.

1. Диагноз? Степень тяжести? Обоснование.
2. Нужна ли магнезия? Почему да или нет?
3. Назначен аспирин 150 мг на ночь. Правильно ли это? Почему?
4. Через 3 дня: АД 170/112 мм рт. ст., головная боль, «мушки». Тромбоциты $95 \times 10^9/\text{л}$. Что изменилось? Какова тактика теперь?

Случай 2. Живот после родов

Родильница, 30 лет, 5-й день после кесарева сечения (показание — тяжёлая преэклампсия на 37-й неделе). Магнезию отменили через 24 часа после родов. Сильная головная боль, тошнота, боль в эпигастрии. АД 175/115 мм рт. ст. Отеки лица.

1. Что подозревать? Два диагноза.
2. «Она же родила, преэклампсия закончилась» — это правильное рассуждение?
3. Действия бригады.
4. Какой анализ крови нужен в первую очередь и что в нём искать?

Случай 3. Подруга позвонила

Беременная, 22 года, срок 38 недель. Звонок подруги: сидела за столом, схватилась за живот, упала и начала трястись; сейчас лежит, не отвечает. На полу, без сознания, дыхание шумное, на губах — розоватая пена. Лежит на спине. АД 190/125 мм рт. ст. ЧСС 120 в минуту. SpO_2 88 %.

1. Какое самое первое физическое действие? Не «оценить» — что делают руками?
2. Сатурация 88 %. Чем это объяснить? Минимум две причины.
3. Полный алгоритм помощи — по пунктам, в хронологическом порядке.
4. Муж спрашивает: «Она умрёт? Что с ребёнком?» Что сказать — два-три предложения.

Случай 4. Перепутать легко

Беременная, 35 лет, срок 33 недели. Тошнота, рвота, боль в правом подреберье 2 дня. Температура 37,3 °C. АД 135/88 мм рт. ст. ЧСС 92 в минуту. Белок в моче не проверяли. Отеков нет.

1. С какими хирургическими заболеваниями дифференцировать? Минимум три.
2. Что заставит заподозрить HELLP? Какой простой анализ может помочь на месте?
3. АД 135/88 мм рт. ст. — это «нормальное» давление для беременной?
4. Решение везти в хирургию. Правильно ли это? Куда нужно?

Случай 5. Два пациента

Беременная, 29 лет, срок 31 неделя. Тяжёлая преэклампсия: АД 165/108 мм рт. ст., головная боль, протеинурия. Введены MgSO_4 4 г, поддержка 1 г/ч, нифедипин 10 мг внутрь. АД стабилизировалось 140/90 мм рт. ст. Путь в стационар 3-го уровня — 25 минут.

На 15-й минуте: внезапная резкая боль в животе. Живот стал доскообразно напряжён. АД упало до 90/60 мм рт. ст. ЧСС 130 в минуту. SpO₂ 96 %. Из влагалища — тёмная кровь.

1. Что произошло?
2. Почему это произошло именно сейчас?
3. Действия в машине — по пунктам.
4. Кто в большей опасности — мать или плод?
5. Что сказать стационару, обновляя информацию?

Решения

Случай 1

1. Преэклампсия умеренная, без тяжёлых признаков. АД $\geq 140/90$ мм рт. ст. после 20 недель плюс протеинурия $\geq 0,3$ г/сут. Нет критериев тяжести: АД ниже 160/110 мм рт. ст., нет неврологической симптоматики, тромбоциты и трансаминазы в норме. Факторы риска: первая беременность, ЭКО, возраст.
2. Нет. $MgSO_4$ показана только при тяжёлой преэклампсии — профилактика судорог — или при эклампсии. При умеренной не назначается.
3. Неправильно. Аспирин — профилактика преэклампсии, не лечение. Его назначают с 12 недель, до 16, пациенткам из группы риска. Сейчас 28 недель — профилактическое окно упущено, плацентация завершена. Лечение — антигипертензивная терапия и наблюдение.
4. Прогрессия до тяжёлой преэклампсии: АД $\geq 160/110$ мм рт. ст., неврологическая симптоматика, тромбоцитопения $< 100 \times 10^9$ /л, возможно начало HELLP. Тактика: $MgSO_4$ 4 г внутривенно за 10–15 мин, затем 1 г/ч; нифедипин внутрь или урапидил внутривенно, цель 130–150/80–95 мм рт. ст.; экстренная госпитализация в стационар 3-го уровня; кортикостероиды для профилактики РДС плода — решение стационара; решение о родоразрешении — в стационаре.

Случай 2

1. Постпартальная эклампсия (угроза) — тяжёлая преэклампсия после родов. HELLP-синдром — боль в эпигастрии плюс тяжёлая гипертензия после преэклампсии.
2. Категорически неправильно. Эклампсия может развиваться до 28 суток после родов. 38 % всех эклампсий возникают в послеродовом периоде. 5-й день — зона высокого риска, особенно если магнезию отменили рано.
3. Левый бок. Венозный доступ, мониторинг. $MgSO_4$ 4 г внутривенно за 10–15 мин, затем 1 г/ч — возобновить. Антигипертензивная терапия: нифедипин 10 мг внутрь или урапидил внутривенно, цель ниже 160/110 мм рт. ст., не ниже 130/80. Срочный перевод в ОРИТ. Готовность к судорогам и интубации.
4. Общий анализ крови и биохимия. Тромбоциты $< 100 \times 10^9$ /л подтверждают LP в HELLP. АСТ/АЛТ выше двух норм — EL. ЛДГ, непрямой билирубин, гаптоглобин, шизоциты — гемолиз. Креатинин — функция почек.

Случай 3

1. Поворот на левый бок. Лежит на спине — аортокавальная компрессия и риск аспирации: нет сознания, есть пена.
2. Аспирация — рвота или пена плюс положение на спине. Апноэ во время тонической фазы. Возможный отёк лёгких как осложнение тяжёлой преэклампсии. Аортокавальная компрессия снижает сердечный выброс и доставку кислорода.
3. Левый бок немедленно. Очистить рот, воздуховод если допускает. Кислород высоким потоком, маска с резервуаром 15 л/мин, цель $SpO_2 \geq 95$ %. Два венозных доступа, монитор. $MgSO_4$ 25 % — 16 мл (4 г) внутривенно за 10–15 мин, поддержка 1 г/ч. Урапидил 12,5–25 мг внутривенно медленно. Глюкоза крови. Оценка сознания после приступа. Госпитализация в стационар 3-го уровня с предупреждением. Готовность к интубации при ШКГ ≤ 8 или повторных судорогах. Транспортировка на левом боку.

4. Не обещать исход. Не пугать. Переключить на полезное действие: документы, полис, одежда.

Случай 4

- 1.** Острый холецистит. Острый панкреатит. Аппендицит — у беременных смещён вверх, на 33-й неделе это правое подреберье. Гастрит, язвенная болезнь. Острый жировой гепатоз беременных.
- 2.** Боль в правом подреберье у беременной после 20 недель — HELLP, пока не доказано иное. АД на верхней границе нормы не снимает диагноз: HELLP бывает и без тяжёлой гипертензии. На месте — тест-полоска мочи на белок. Протеинурия плюс боль в правом подреберье качает весы в сторону HELLP.
- 3.** 135/88 мм рт. ст. формально ниже порога 140/90. Это может быть повышением для данной пациентки. Во II триместре АД физиологически снижается; 135/88 к III триместру может быть относительной гипертензией. HELLP может протекать при «нормальном» АД.
- 4.** Неправильно. При подозрении на HELLP нужен акушерский стационар 2–3-го уровня, не чистая хирургия. Беременная после 20 недель с болью в животе едет в акушерский стационар, даже если картина кажется хирургической.

Случай 5

- 1.** Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты — осложнение тяжёлой преэклампсии.
- 2.** Тяжёлая преэклампсия даёт генерализованный эндотелиоз и повреждение сосудов маточно-плацентарной площадки. Снижение АД могло дать относительное падение перфузии, ишемию, ретроплацентарную гематому и отслойку. Тромбоцитопатия и латентный ДВС расширяют гематому.
- 3.** Левый бок. Кислород высоким потоком. Вторая вена, кристаллоиды болюсно. Не останавливаться, ехать максимально быстро, оповестить стационар. MgSO₄ не отменять — риск эклампсии не снят. Считать кровопотерю. Утеротоники на догоспитальном этапе не вводить: плод в матке.
- 4.** Оба в критической опасности, плод — в непосредственной. При отслойке больше 50 % — антенатальная гибель за минуты. У матери видимая кровопотеря меньше реальной: часть крови ретроплацентарно. ДВС. Матка Кувелера. Спасение обоих — экстренное кесарево сечение.
- 5.** Ситуация изменилась. Тяжёлая преэклампсия, подозрение на отслойку: доскообразный живот, кровотечение, АД 90/60 мм рт. ст., плод 31 неделя. Нужны экстренная операционная и реаниматологи.

Основные выводы

№	Вывод
1	Умеренная преэклампсия — без магнезии. Аспирин после 16 недель уже не лечение. Нифедипин — внутрь, не под язык.
2	Эклампсия живёт до 28 суток после родов. «Она же родила» — не аргумент. Магнезию возобновить.
3	Беременная без сознания на спине — сначала левый бок, потом всё остальное.
4	Боль в правом подреберье после 20 недель — HELLP, пока не доказано иное. Даже при АД 135/88. Не в хирургию.
5	Доскообразный живот и тёмная кровь на фоне преэклампсии — отслойка. Видимая кровь меньше реальной. Ехать, не ждать.